

27 - 03- Occlusions Intestinales Aigues - Pr. Benelkhaïat

(0:01 - 0:36)

L'occlusion intestinale aiguë est une urgence médico-chirurgicale. On rappelle que l'occlusion peut être haute lorsqu'elle intéresse l'intestin grêle, le jejunum, mais aussi l'illium. Elle est dite basse lorsqu'elle intéresse le colon, lorsque l'obstacle siège soit au niveau du sécum, du colon ascendant, l'ongle colique, le transverse ou bien l'ongle colique gauche, ou voire même au niveau du rectum.

(0:38 - 0:51)

La séméiologie est très importante à rappeler. Une occlusion basse est caractérisée par une distanciation abdominale très importante. La douleur est moins importante.

(0:51 - 1:12)

Quant à l'arrêt des matières et des gaz, il est tardif. Au contraire, l'occlusion intestinale haute est caractérisée par un arrêt des matières et des gaz tardifs. Alors, les vomissements sont alimentaires et la douleur est très importante.

(1:13 - 1:28)

Comme introduction, on va dire que l'occlusion intestinale aiguë, c'est l'arrêt complet des matières et surtout des gaz. Les étiologies sont très variées. Les plus fréquentes au niveau du grêle, ce sont les brides et les adhérences.

(1:29 - 1:53)

Quant à l'étiologie la plus fréquemment rencontrée au niveau du colon, ce sont essentiellement les tumeurs. Malheureusement, les tumeurs du colon, les cancers du colon sont diagnostiqués à un stade tardif, au stade d'occlusion intestinale aiguë. L'occlusion, qu'elle soit d'origine haute ou basse, a des répercussions générales très importantes.

(1:53 - 2:29)

Et on va voir que la physiopathologie est très importante à connaître parce qu'il ne s'agit pas de traiter uniquement l'étiologie, mais la mise en condition et le traitement médical est très important. Le pronostic est variable selon l'étiologie de l'occlusion. Autant il peut être bon quand il s'agit d'une bride qui enrêgle son problème, alors que le pronostic peut être mauvais lorsqu'il s'agit d'un cancer très évolué diagnostiqué au stade d'occlusion.

(2:32 - 2:54)

Les mécanismes de l'occlusion intestinale aiguë peuvent être de type mécanique. Une

obstruction, une strangulation comme c'est le cas dans l'ernie. Toute ernie peut se compliquer d'une occlusion intestinale aiguë lorsque le contenu intestinal n'est plus réductible.

(2:55 - 3:17)

C'est une urgence, c'est une extrême urgence parce que c'est une course contre la montre pour sauver l'intestin de la nécrose et de la perforation. Donc, mécanisme de la strangulation. Les adhérences et les brides se voient essentiellement dans l'abdomen cicatriciel.

(3:17 - 3:42)

Quand le patient a déjà été opéré, tout stress chirurgical expose le patient le restant de sa vie à développer une occlusion par bride et adhérence. Et le délai d'apparition de cette occlusion est très variable. On ne peut pas prévoir ou prévenir les adhérences.

(3:43 - 4:29)

Un autre mécanisme c'est l'intussection qui se voit essentiellement quand l'intestin présente une petite tumeur. Donc, ce mécanisme, autant il est primaire, c'est-à-dire sans lésion chez le nourissant, l'invagination. L'invagination primaire est fréquente chez le nourissant, mais chez l'adulte, il faut toujours chercher une cause, une petite tumeur, un lipome, un diverticule de mésentère ou autre lésion qui peut expliquer l'invagination chez l'adulte.

(4:29 - 5:01)

Un autre mécanisme de la strangulation, c'est le volvulus. C'est la torsion de l'intestin au cours de son axe vasculaire. Ce mécanisme expose aussi à la nécrose au bout de quelques heures la viabilité de l'intestin et les complications, dont la nécessité d'opérer rapidement le volvulus, mais aussi l'hernie étranglée.

(5:02 - 5:25)

Voici un patient qui a une hernie ombilicale. Même une petite hernie expose au risque de strangulation ou d'étranglement. Aussi, l'hernie inguinale chez l'homme expose au risque de strangulation.

(5:26 - 5:46)

Ce sont des mécanismes mécaniques qui peuvent expliquer l'occlusion intestinale. L'occlusion peut être fonctionnelle. C'est ce qu'on appelle l'hilaïus réflexe, la paralysie intestinale, qui se voit au cours des infections et des sepsis.

(5:46 - 6:04)

La péritonite s'accompagne d'un hilaïus réflexe. On peut avoir des niveaux hydraïriques chez le

patient qui a une péritonite. On peut avoir des niveaux hydraïriques sur l'ASP debout, mais aussi sur le scanner.

(6:05 - 6:30)

L'hilaïus réflexe peut accompagner une pancréatite aiguë. On peut voir sur le scanner des onces sentinelles qui sont au contact du foyer inflammatoire de la loge pancréatique. Donc tout foyer infectieux peut provoquer une occlusion fonctionnelle.

(6:31 - 6:57)

Ce mécanisme se voit également chez le patient qui a subi une intervention sous anesthésie générale. On sait très bien que les médicaments de l'anesthésie entraînent une paralysie qui est proportionnelle à la quantité, à la dose. Plus l'intervention est longue, plus la récupération du transit est tardive.

(6:57 - 7:41)

Les conséquences de l'occlusion, lorsqu'un obstacle siège sur le transit, il entraîne une distension intestinale en amont de l'obstacle avec une altération de l'absorption et des troubles de la microcirculation, ce qui engendre une souffrance de la paroi intestinale et une altération des secteurs hydriques. Je rappelle qu'au niveau de l'intestin, il y a un mouvement hydrique très important. Un litre et demi de salive par 24 heures est sécrétée et déglutie inconsciemment.

(7:41 - 8:12)

Ajoutez à ceci un litre et demi de sucre gastrique, de sécrétion gastrique. Ajoutez à ceci 800 cc par jour de bile et un litre et demi de sucre pancréatique. Donc si on fait le total de ces sécrétions, on va retrouver qu'il y a six litres par jour de liquide qui est récupéré et réabsorbé au niveau du jejunum.

(8:12 - 8:47)

C'est ce qu'on appelle le mouvement très important des liquides du milieu intérieur qui sont récupérés. Lorsqu'il y a un obstacle, cette masse liquidienne forme ce qu'on appelle le troisième secteur qui ne participe plus aux échanges. Donc une quantité très importante de liquide et aussi d'électrolytes, puisque ce liquide est riche en sodium, potassium, calcium.

(8:48 - 9:30)

Donc on va assister à des troubles hydriques qui peuvent accompagner ce tableau d'occlusion intestinale aiguë. D'où la nécessité d'un remplissage par voie veineuse chaque fois qu'on admet un patient qui présente une occlusion intestinale aiguë pour éviter le choc hypovolémique et éviter les troubles de tension artérielle. Donc la mise en condition du patient et la prise de voie

veineuse doivent être primordiales avant d'envoyer le patient pour faire des explorations radiologiques.

(9:32 - 10:06)

Cette altération des secteurs hydriques constitue une séquestration liquidienne et forme ce qu'on appelle le troisième secteur. Ce troisième secteur explique la baisse de la tension artérielle, le choc hypovolemique, mais aussi le pli cutané qu'on peut dire. L'arrêt de matière et des gaz est un signe trempé puisqu'on peut avoir des gaz même en cas d'occlusion.

(10:07 - 10:27)

Lorsque l'obstacle est haut situé, sur le gilet jaune par exemple, l'intestin continue à purger son contenu. C'est forcément rassurant quand on a un transit. Ça n'élimine en rien le diagnostic d'occlusion intestinale aiguë.

(10:28 - 11:17)

Le météorisme et la distanciation abdominale peuvent être absentes en cas d'obstacle haut situé sur le gilet jaune ou l'idiot. Mais quand l'obstacle siège sur le collant, dans les occlusions basses, la distanciation abdominale est très importante. Les signes généraux qui accompagnent l'occlusion intestinale aiguë, c'est essentiellement la déshydratation qui s'explique par la constitution de ce troisième secteur, la séquestration de masse liquidienne importante dans la lumière de l'intestin et le fait que le milieu intérieur est privé des échanges expliquent cet état de déshydratation.

(11:17 - 11:32)

Accompagné de ceci, on peut observer une atterration de l'état général. Ces signes généraux permettent d'apprécier le retentissement du syndrome occlusif. La prise de température doit être systématique.

(11:32 - 11:59)

L'existence d'une fièvre doit tirer le signal d'alarme et orienter vers un risque de nécrose intestinale qui constitue un élément de gravité. Les signes physiques, à l'inspection, on doit observer la distanciation de l'abdomen. Parfois, chez les sujets maigres, on peut observer des ondulations péristaltiques sous la peau.

(11:59 - 12:37)

Également, on doit rechercher une cicatrice de l'abdomen, une cicatrice de la parotomie antérieure qui peut, dès lors, nous orienter vers le diagnostic le plus fréquemment rencontré dans l'intestin grêle, que sont les brides et les adhérents. Voici un patient avec une cicatrice de

médiane sous-ombilicale. Ici, on doit s'orienter, si le patient se présente pour syndrome occlusif, vers une occlusion sur brides et adhérents.

(12:38 - 13:09)

Par un toucher rectal qui doit être systématiquement réalisé, chercher une ampoule vide en faveur d'occlusion. Si jamais le doigtier revient souillé de sang, il peut orienter vers une tumeur du côlon, du rectum ou vers une nécrose intestinale. Donc, le toucher rectal nous fournit pas mal de renseignements à analyser en fonction du contexte.

(13:12 - 13:38)

Les signes radiologiques, le premier examen complémentaire à demander, c'est l'ASP debout, de face. Il faut insister sur le fait que l'ASP doit être fait debout et de face. Il doit rechercher des niveaux hydroaériques selon le nombre des niveaux hydroaériques et selon leur disposition.

(13:39 - 13:51)

Par exemple, ici, ça oriente vers un obstacle grélique. Les niveaux sont plus larges qu'haut. Ils sont étagés.

(13:51 - 14:47)

Ils sont trop hauts. Donc, c'est un obstacle qui siège normalement sur le grél. Les niveaux coliques sont plutôt périphériques.

Ils sont plus hauts que larges. Il faut chercher des illustrations coliques. Donc, voici des niveaux coliques périphériques.

Ils sont plus hauts que larges. Le scanner, il est fondamental. Maintenant, l'ATDM est présente partout aux urgences.

Donc, elle confirme le diagnostic d'occlusion en montrant des ondes distendues, pleines de liquide. Elle montre les niveaux hydroaériques. On voit très bien ici que les ondes gréliques sont pleines.

(14:48 - 15:51)

Et on voit le siège d'une disparité de calibre. Donc, la précision du diagnostic est de l'ordre de 70 à 95 %. Donc, le scanner est important dans le diagnostic d'occlusion intestinale. Selon le segment intéressé, il peut s'agir d'intestin grél proximal.

Dans ce cas, le début de la douleur est brutal. Il est précoce. Les vomissements sont alimentaires au milieu.

La distension abdominale est discrète ou absente. Avec une atterrision rapide de l'état général et des ASP de type grélique, c'est-à-dire plus larges que hauts, sans trop étager. Lorsqu'il s'agit de grêle distale, on peut avoir la même sémiologie radiologique qu'on observe sur le collant.

(15:51 - 16:24)

Pour le collant, le début est progressif. Les vomissements sont tardifs. Le météorisme est important.

La distension abdominale est très importante. Déjà sur l'ASP, on remarque des niveaux plus hauts que larges. Selon le mécanisme, quand il s'agit d'un foyer inflammatoire intraperitonial, tel qu'une appendicite dans sa forme mésocélique, une colicite, une pancréatite, tous peuvent s'accompagner d'un ileus réflexe.

(16:24 - 16:39)

Les signes généraux de l'inflammation sont présents, notamment la fièvre. Le météorisme est important. Sur l'ASP, on remarque des niveaux mixtes, c'est-à-dire grélique et de type colique.

(16:39 - 16:52)

On peut même observer de l'air au niveau du rectangle. On était en train de parler du mécanisme de l'astronomie. Dans ce cas, la douleur est vive.

(16:54 - 18:25)

L'obstruction de la lumière a été une pointe de vue fréquente après les occlusions sur Bride. Les hernies étranglées, dans notre contexte, c'est une cause fréquente, méconnue, non traitée, l'hernie. Le patient, un jour, va se présenter pour une douleur très importante, une hernie qui n'est plus réductible, qui n'est plus extensible à la toux.

Le risque de nécrose est très important. En général, il y a un délai de six heures au-delà duquel le patient court le risque de nécrose et de résection intestinale. Le diagnostic doit être clinique.

C'est la palpation des orifices hernières, comme on l'a dit tout à l'heure. Un autre mécanisme de l'obstacle sur l'intestin grêle, c'est l'ileus biliaire. Ce diagnostic est devenu de plus en plus rare, puisque la prise en charge de la lithiase de l'ileus biliaire se fait de plus en plus, même dans les milieux les plus défavorisés, dans les milieux ruraux, lointains.

(18:25 - 19:08)

Cette migration de calcul à travers une fistule bilioduodénale, le calcul de gros calibres centimétriques, qui va venir obstruer la lumière de l'ileon et empêcher le transit. Des éléments en faveur, c'est l'antécédent de coliques hépatiques. Une échographie faite dans les antécédents, le

scanner peut montrer une aérobie, c'est-à-dire du gaz qui va tracer la raborisation biliaire intrahépatique.

(19:08 - 19:50)

Ce sont des éléments en faveur de ce diagnostic d'ileus biliaire, qui heureusement est devenu un peu rare, voire même exceptionnel. Autres mécanismes qui peuvent être observés concernant l'obstacle sur l'intestin grêle, ce sont les bézoars, avec deux types, les phytobézoars et les trichobézoars. Phytobézoar veut dire des végétaux ingérés, ou bien trichobézoar, ce sont des patients avec un certain nombre de profils psychologiques qui arrachent leurs cheveux, surtout les jeunes filles arrachent les cheveux.

(19:51 - 20:38)

Avec le temps, avec les semaines et les jours, les cheveux vont s'agglutiner au niveau de l'estomac, et peuvent même migrer et entraîner un tableau d'occlusion intestinale aiguë. Autres mécanismes qui peuvent s'observer chez les enfants, cette fois-ci ce sont les corps étrangers ingérés et avalés, donc il faut faire attention chez les enfants, surtout les jouets, chez les enfants de bas âge, ils peuvent les ingérer et entraîner une occlusion intestinale aiguë. Les tumeurs du grêle et les cancers, heureusement ils sont rares, voire même exceptionnels.

(20:38 - 21:33)

Ceci s'explique par la rapidité du transit au niveau de l'intestin grêle. En général, ça dure une trentaine de minutes le transit au niveau du grêle, et donc cette rapidité du transit explique que les agents carcinogènes de l'alimentation ont peu de temps de rester en contact avec les enterocytes, avec les cellules de la muqueuse du grêle, et entraîner, je pense que c'est une explication de la rareté des cancers au niveau de l'intestin grêle. D'autres étiologies beaucoup plus rares, ce sont les parasites qui peuvent se voir essentiellement chez les enfants.

(21:35 - 22:13)

Certains parasites peuvent entraîner un tableau d'occlusion intestinale. Les occlusions du côlon, malheureusement le cancer du côlon est endémique dans notre contexte, dans notre pays, le Maroc, le cancer du côlon est fréquent, et malheureusement il est diagnostiqué au stade d'occlusion. Le fait que le cancer soit diagnostiqué au stade d'occlusion est un facteur de mauvais pronostics.

(22:14 - 22:50)

Souvent c'est un cancer du côlon gauche, c'est-à-dire le cirmoïde ou bien le côlon ascendant ou l'ongle colique gauche. La distension abdominale est très importante, avec une installation progressive, et parfois comme je l'ai cité tout à l'heure, chez les sujets âgés, ils peuvent même adapter leur alimentation et arrêter de manger et rester plusieurs jours. On a vu des patients qui

ont été diagnostiqués des semaines après l'occlusion intestinale.

(22:51 - 23:21)

Une autre étiologie qui est très fréquemment rencontrée dans notre contexte marocain, c'est le volulus du sigmoïde. Ce volulus du sigmoïde est favorisé par l'excès de longueur qu'on appelle le dolico-sigmoïde. Parfois la longueur du sigmoïde expose à cette urgence médico-chirurgicale qui est le volulus.

(23:21 - 23:46)

L'excès de longueur du colon sigmoïde avec un mesocore facilite sa torsion. Il va faire des torsions d'un tour de spire, voire même un tour et demi, deux tours de spire autour de son axe vasculaire. C'est un tableau d'occlusion basse avec une distension abdominale très importante.

(23:46 - 24:05)

À l'ASP, il faut chercher ce qu'on appelle une image de double jambage caractéristique. On va voir cette radio sur cet ASP de face. Voici des niveaux de type colique plus haut que large.

(24:05 - 24:18)

La hauteur est très importante. C'est un diagnostic de volulus du sigmoïde. Un autre patient avec un volulus de sigmoïde.

(24:18 - 24:56)

C'est une urgence chirurgicale car si le patient n'est pas pris en charge rapidement, cet ans sigmoïde volvulé est exposé au risque de nécrose et donc de perforation. Dans ce cas, le tableau clinique va être beaucoup plus grave puisque c'est une perforation colique avec une péritonite tertiaire qui va aggraver le tableau clinique. Autre diagnostic qui peut expliquer l'occlusion intestinale aiguë, c'est le syndrome d'Augervie.

(24:57 - 25:23)

C'est une distension colique très importante. La pression intraluminaire devient supérieure à la tension développée par la musculature de la paroi du colon. Ce syndrome d'Augervie se voit surtout chez les sujets âgés.

(25:24 - 25:52)

Le traitement consiste à une exsufflation qui peut être exécutée par un gastro-entérologue. Une exsufflation par colonoscopie. Il faut agir rapidement avant l'aggravation du tableau clinique et l'installation de signes de nécrose.

(25:52 - 26:10)

Autre étiologie d'occlusion colique, c'est la diverticulose. La diverticulose se développe essentiellement et surtout au niveau du sigmoïde. La diverticulose est très rare dans notre contexte marocain.

(26:10 - 26:34)

Par contre, elle est fréquente dans les pays européens. Cette diverticulose peut se compliquer d'un tableau d'occlusion, de diverticulite qui peut s'accompagner d'un ileus intestinal. Autre étiologie qu'on peut voir au niveau du colon, ce sont les corps étrangers.

(26:36 - 27:05)

Je vous laisse deviner la gravité de ce tableau d'occlusion intestinale aiguë. Pour le traitement, la mise en condition est très importante. Il faut aspirer le contenu gastrique et l'évaluer, puisque l'évaluation de la quantité récupérée par la sonde gastrique va nous permettre une réanimation correcte.

(27:05 - 27:34)

Il faut réanimer en fonction des pertes gastriques, mais aussi des pertes de la sonde urinaire. Le remplissage vasculaire va compenser l'état de choc hypovolémique. On a parlé tout à l'heure de la constitution de ce troisième secteur, qu'il va falloir remplir par une bonne voie veineuse.

(27:36 - 28:16)

Il faut savoir que la mise en condition est très importante. Elle peut même éviter une reprise chirurgicale, surtout dans le cas d'un malade qui a un tableau d'occlusion intestinale sur bride et adhérence. Une bonne mise en condition et un traitement médical et une surveillance rapprochée peuvent éviter une reprise chirurgicale, mais à condition de bien surveiller le malade et d'éliminer une nécrose intestinale.

(28:16 - 28:59)

On peut éviter une intervention chirurgicale, puisqu'elle va être une source d'aggravation ou d'exposition à un nouveau tableau d'occlusion sur bride. Rien qu'avec la mise en condition, l'analgésie et le remplissage vasculaire, la sonde gastrique et cette mise en condition peuvent éviter une reprise chirurgicale chez un patient qui a un tableau d'occlusion sur bride et adhérence. Pour la chirurgie, il faut rechercher la cause au niveau de l'intestin grêle.

(28:59 - 29:19)

On a vu que les étiologies les plus fréquemment rencontrées sont les brides et les adhérences,

les hernies étranglées. Il faut lever l'obstacle, surtout s'il s'agit d'une hernie étranglée. Il faut agir rapidement pour éviter la nécrose intestinale.

(29:20 - 29:46)

Plus on agit rapidement, plus on évite cette nécrose intestinale. Il faut apprécier la vitalité de l'intestin grêle. Je rappelle que la vitalité de l'intestin grêle est appréciée sur la recoloration, la reprise de la coloration de l'intestin, la reprise du péristaltisme et sur la perception du pot mésentérique.

(29:47 - 30:13)

Cette chirurgie doit s'accompagner d'une vidange de grêle à l'aide d'une sonde gastrique. Une coopération avec le médecin anesthésiste réanimateur est très importante, surtout pour éviter de laisser, après le geste chirurgical, un estomac qui est plein. On sait très bien que le patient, au moment du réveil, peut vomir.

(30:13 - 30:36)

Surtout s'il est avec un réveil qui tarde, qui ne se fait pas d'hier. Le patient peut vomir et inonder ses poumons. Il faut éviter le syndrome de Mendelsohn avec une bonne vidange, avec une sonde gastrique et une aspiration de tout le contenu gastrique.

(30:38 - 31:08)

L'endoscopie peut être le traitement, comme on l'a vu tout à l'heure, de volvulus de sigmoïdes. Si on est sûr de l'absence de signes de nécrose, on peut tenter une détorsion par un tube de fauché. On peut tenter une exsufflation dans le cas du syndrome d'Augilvy, cette distension du cadre colique qui se voit chez le sujet âgé.

(31:09 - 31:32)

Une sonde rectale avec un rectoscope permet de détendre le col en sigmoïdes tordus. Les indications sont en fonction de la cause de l'occlusion intestinale aiguë. En cas de bride, un traitement médical doit être instauré dans tous les cas.

(31:33 - 31:49)

On peut même espérer une reprise du transit et éviter le geste chirurgical. Mais si échec de cette mise en condition, la chirurgie s'impose. C'est en fonction de l'état local.

(31:50 - 32:19)

Il peut s'agir d'un geste rapide et facile, section d'une bride et fermeture. Il peut s'agir d'un geste difficile, laborieux, qui dure plusieurs minutes, plusieurs heures, voire même quand il s'agit de

deux brides d'adhérence qui intéressent tout l'intestin grêle. Donc la désiolise et la viscérolise peuvent être très difficiles et laborieuses.

(32:20 - 32:42)

La chirurgie peut intéresser une hernie. Il faut vérifier la viabilité de l'ence qui était incarcérée, étranglée. Il faut, coûte que coûte, réintroduire l'ence intestinale dans l'ence ardominale et vérifier sa viabilité.

(32:42 - 33:11)

Il faut également faire et réaliser la cure de la hernie selon l'état local. On peut même utiliser des plaques si l'état local le permet. En cas de cancer du côlon, la chirurgie peut s'agir soit d'une colectomie avec réduction de la tumeur ou bien d'une colostomie.

(33:12 - 33:56)

On peut, dans certaines conditions, lorsqu'il s'agit par exemple d'un malade opéré le soir ou un jour férié, un jour de week-end, on peut se contenter d'une colostomie première pour permettre la reprise du transit et la préparation du côlon et reprendre le patient par la suite pour une résection de cette tumeur. Donc c'est en fonction des cas à discuter. Le volvulus du sigmoïde, on peut toujours tenter une détorsion par un tube de fauché ou par endoscopie.

(33:57 - 34:28)

Et la chirurgie, si échec ou si signe de gravité, c'est-à-dire qu'on suspecte une nécrose de cet ensigmoïde volumelé, dans ce cas, on doit réagir et intervenir par la chirurgie pour réaliser une résection de cet ensigmoïde nécrosé. En conclusion, on va dire que l'occlusion intestinale est vue. C'est une urgence médico-chirurgicale.

(34:29 - 35:07)

Les causes sont très variées. L'essentiel, c'est qu'il faut faire le diagnostic, hospitaliser le patient et demander les avis spécialisés, demander les examens complémentaires pour arriver au diagnostic étiologique. Il faut savoir reconnaître la cause, mais aussi proposer une mise en condition par des gestes tels que la sonde gastrique, le remplissage vasculaire et, en fonction des cas, proposer un traitement adapté.